

Diabetes mellitus stationär — KP-Kernversion

Hochrelevante Essentials für die Kenntnisprüfung · deutsche Klinikpraxis (DDG / NVL)

Eiserne Regeln

- Typ 1: Basalinsulin NIE weglassen — auch nüchtern oder krank, sonst Ketoazidose.
- BZ-Ziel stationär 140–180 mg/dl; nicht zu streng einstellen (Hypogefahr).
- Hypoglykämie < 70 mg/dl. Bei Niereninsuffizienz Insulindosis reduzieren.

Hypoglykämie (Notfall)

- Wach: 15-g-Regel — 15 g schnelle KH (Traubenzucker/Saft), nach 15 min BZ-Kontrolle, ggf. wiederholen.
- Bewusstlos: Glukose i.v. (z. B. 20–40 ml G40) oder Glukagon 1 mg i.m./s.c.

Basal-Bolus & eine Dosis nennen

- Prinzip: Basal (langwirksam) + Bolus (kurzwirksam) zu den Mahlzeiten + Korrektur.
- Start insulin-naiv ca. 0,5 IE/kg/Tag, etwa 50 % Basal / 50 % Bolus.
- Faustregel: 1 IE senkt BZ um ~30–40 mg/dl.

BZ (mg/dl)	Korrektur
< 70	Hypo → kein Insulin, 15 g KH
70–150	0 IE (nur Mahlzeit)
151–200	+2 IE
201–250	+4 IE
251–300	+6 IE
301–350	+8 IE
> 350	+10 IE, Ketone prüfen

- Sliding Scale nie als alleinige Therapie.

Diabetische Ketoazidose (DKA)

- Reihenfolge: 1. Volumen (NaCl 0,9 %) → 2. Insulin-Perfusor 0,1 IE/kg/h i.v. → 3. Kalium.
- Perfusor: 50 IE Normalinsulin / 50 ml NaCl → 1 IE/ml.
- BZ < 250 → Glukose dazu, Insulin weiter, bis Azidose behoben.
- K^+ < 3,3 mmol/l → zuerst Kalium (Insulin treibt K^+ in die Zelle).
- Umstellung auf s.c.: Basalinsulin 1–2 h vor Perfusorstopp geben.

Perioperativ / nüchtern

- Metformin am OP-Tag pausieren (Laktatazidose, Kontrastmittel).
- Sulfonylharnstoffe am OP-Tag pausieren (Hypo bei Nüchternheit).
- SGLT2-Hemmer perioperativ absetzen — Gefahr euglykämie Ketoazidose.
- Typ 1: Basalinsulin weiter (ggf. reduziert), Bolus bei Nüchternheit weglassen.
- Große OP / lange nüchtern → Insulin-Perfusor + Glukose, BZ engmaschig.

Krankheitstage (Sick Days)

- Insulin nie absetzen — Bedarf steigt bei Krankheit.
- BZ engmaschig; Ketone bei BZ > 250 oder Erbrechen.
- Ausreichend trinken; bei Hyperglykämie + Ketonen mehr (Korrektur-)Insulin.

Glossar — Abkürzungen

BZ	Blutzucker	IE	Internationale Einheit (Insulin)
ICT	Intensiv. konv. Insulintherapie (Basal-Bolus)	TDD	Tagesgesamtdosis (Insulin)
BE	Broteinheit (12 g KH)	KE	Kohlenhydrateinheit (10 g KH)
KH	Kohlenhydrate	NPH	Verzögerungsinsulin (Neutr. Protamin Hagedorn)
s.c.	subkutan	i.v.	intravenös
i.m.	intramuskulär	DKA	Diabetische Ketoazidose
HHS	Hyperosmolares hyperglykäm. Syndrom	SGLT2	Na-Glucose-Cotransporter 2 (Gliflozine)
DPP-4	Dipeptidylpeptidase 4	NaCl	Kochsalzlösung
G40/G10/G5	Glukose 40 / 10 / 5 %	K^+	Kalium
DDG	Deutsche Diabetes Gesellschaft	KP	Kenntnisprüfung

Lernhilfe nach gängiger deutscher Klinikpraxis (DDG-Empfehlungen / Nationale VersorgungsLeitlinie). Beispielschemata — konkrete Dosis individualisieren, lokalen Hausstandard und ärztliche Supervision beachten.